

# CASO CLÍNICO 9

Entendiendo al usuario

GRUPO 14



# CASOS DE REFERENCIA

| DATOS                 | CASO 1                         | CASO 2                                        | CASO 3                                  |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EDAD / SEXO           | 25 AÑOS / MASCULINO            | 51 AÑOS / MASCULINO                           | 25 AÑOS / MASCULINO                     |
| TIPO DE LESION        | CERVICAL TRAUMATICA            | CERVICAL INCOMPLETA                           | T10 – AIS A                             |
| CONSECUENCIA          | TETRAPLEJICA                   | ALTERACIONES MOTORAS Y FUNCIONALES            | PARAPLEJIA COMPLETA                     |
| PROBELMAS PRINCIPALES | DEPENDENCIA DE AVD             | DISFAGIA, PROBLEMAS ESFINTERIANOS Y MOVILIDAD | LESION POR PRESION                      |
| INTERVENCION          | REHABILITACION INTEGRAL        | REHABILITACION INTERDISCIPLINARIA             | MEMBRANA DE FIBRINA RICA EN PLAQUETAS   |
| RESULTADO             | MAYOR DEPENDENCIAL FUNCIONAL   | MEJORA DE MOVILIDAD Y AVD                     | CICATRIZACION COMPLETA                  |
| PUNTO CLAVE           | REHABILITACION → INDEPENDENCIA | TIPO DE LESION → FUNCIONALIDAD                | COMPLICACIONES → SOLUCIONES BIROMEDICAS |

# PERFIL FUNCIONAL

01

## CAPACIDADES CONSERVADAS

- Orientación, conciencia y comunicación
- Movilidad pasiva mayormente conservada



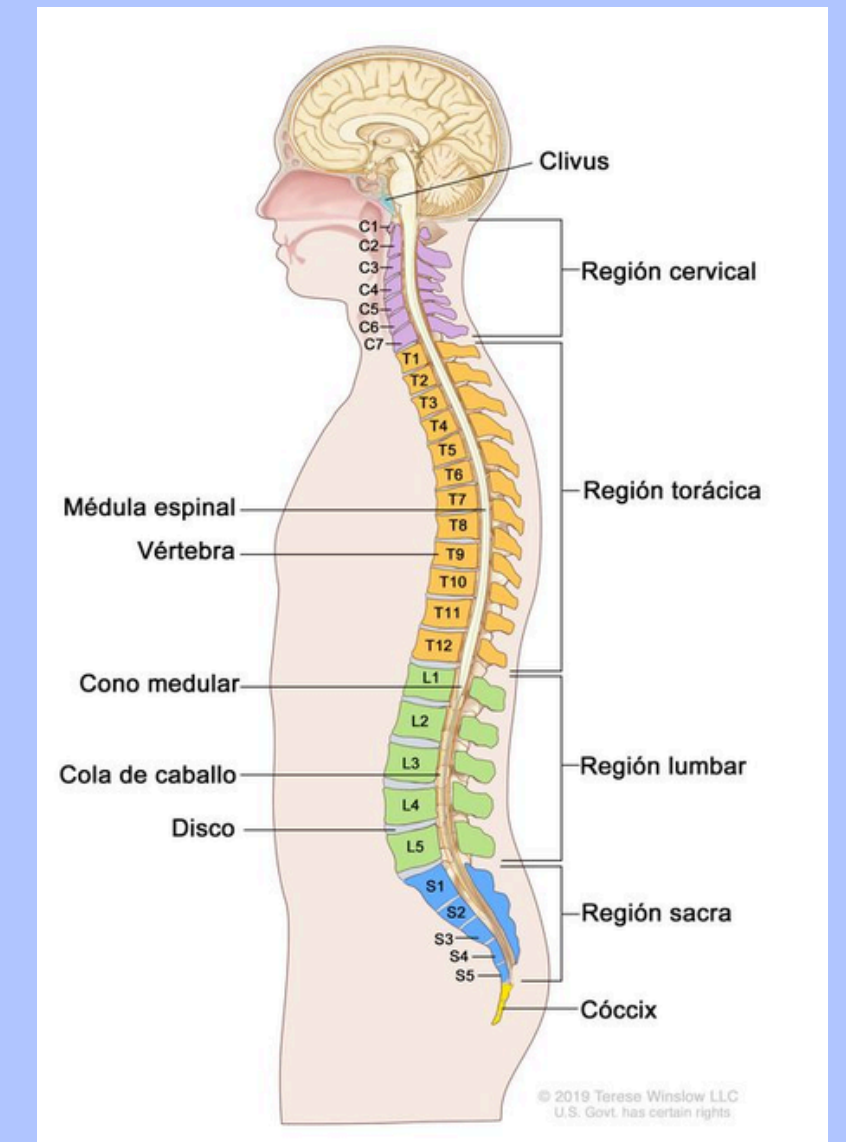
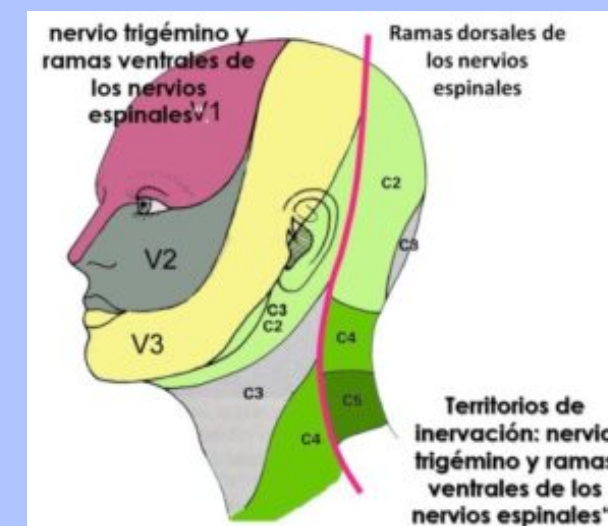
02

## LIMITACIONES

- Movilidad activa miembros superiores: muy disminuida
- Movilidad activa miembros inferiores: ausente
- Fuerza: C5 → 3/3 | C6-S1 → 0/0
- Control de tronco
- Sensibilidad ausente desde C5-S5
- Lesión por presión sacra

## DEPENDENCIA ELEVADA

- Alimentación
- Higiene
- Transferencias
- Movilidad
- Posicionamiento y alivio de presión



# MAPA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

## VIDA DIARIA

- Requiere asistencia para cada actividad debido a su tetraplejía, siendo dependiente de al menos una persona en todo momento;
- Al momento de colocarla en la camilla se hace uso de una grúa para pacientes.

## REHABILITACIÓN:

- Acude a terapia psicológica, sin embargo permanece pesimista sobre su situación y su mejoría.
- A pesar de las terapias es muy dependiente de ayuda externa. (No colabora mucho)

## LABORALES/EDUCATIVAS

- Es económicamente dependiente.
- Su participación social es disminuida y está limitada, reforzado al estar internada.

## ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE PREVENCIÓN/PROGRESIÓN

- Para evitar lesiones por presión mantiene su terapia física, además de prevenir el empeoramiento de su herida en la región sacra.

# BARRERAS Y FACILITADORES

## Barreras (Factores Limitantes)

**Económico / Social:** Dependencia económica total y ausencia del cuidador principal por trabajo.

**Físico / Estructural:** Uso de silla mecánica sin autonomía para desplazarse (depende de terceros).

**Salud Secundaria:** Úlcera sacra severa (Grado III-IV) que limita el tiempo sentada y retrasa la rehabilitación.



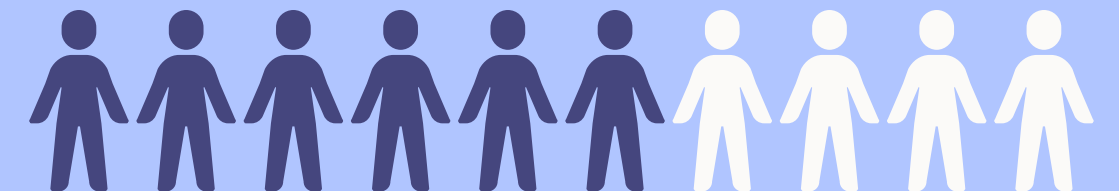
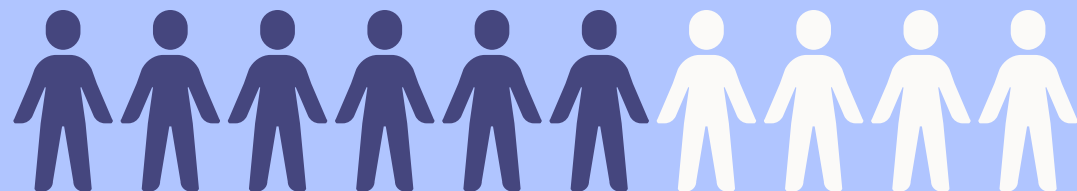
# BARRERAS Y FACILITADORES

## Facilitadores (Factores de Apoyo)

**Social / Institucional:** Respaldo médico, psicosocial y seguimiento continuo por parte del INR.

**Cognición y Comunicación:** Estado lúcido y lenguaje intacto que le permite dirigir su propio cuidado.

**Fisiológico:** Respiración espontánea y deglución conservada (no depende de soporte vital).



# MAPA DE DOLOR (PAIN POINTS)

## Traslado

## Alimentacion e Higiene

## Rehabilitacion

### Descripcion

Al trasladarse de la cama a la silla de ruedas necesita una grua y para el traslado externo depende de la silla de ruedas

Las actividades de vida diaria como alimentarse, vestirse o bañarse quedan fuera de su alcance

Realiza una rehabilitacion integral en el INR en donde se encuentra actualmente hospitalizada

### ¿Que tipo de ayuda requiere?

Usualmente necesita de 1 a 2 personas para el traslado con la grua

Depende totalmente del personal del hospital para sus AVD

Ejercios de rehabilitacion especificos para pacientes con LME a cargo de terapeutas, no realiza los ejercicios por si sola

### ¿Presenta molestias?

Tiene lesiones por presion en la region sacra

Necesita de sonda Foley

Presento dificultades para realizar las terapias debido a su estado psicologico

# EXPECTATIVAS DEL USUARIO

Entre los objetivos y las mejoras que se buscan con respecto a la paciente, tenemos:

## Control del entorno

Lograr que la paciente pueda controlar su entorno de forma remota, para poder activar y desactivar dispositivos sin necesidad de usar sus extremidades.

## Cambios Posturales

Lograr que la paciente pueda retomar control o fortalecer la poca movilidad que queda en sus extremidades.

## Independencia

Lograr que la paciente pueda realizar funciones primordiales por su cuenta. Entre las más importantes tenemos el conseguir que la paciente pueda controlar o al menos cambiar por su cuenta una sonda Fey.

